

DESCRIPCION

El Lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad autoinmune que compromete muchos órganos en diferentes tiempos o en el mismo momento, es decir que además de afectar a las articulaciones y los músculos, puede dañar la piel y múltiples órganos.

Lupus significa “lobo” en latín. Este nombre muy antiguo, se debe a que esta enfermedad puede manchar la cara pareciéndose a las marcas que tienen en el rostro algunos lobos. No son iguales todas las formas de lupus, algunas solamente comprometen la piel (Lupus Cutáneo o discoide) y otras si afectan diferentes órganos incluyendo la piel y es llamado Lupus Eritematoso Sistémico.

Es una enfermedad autoinmune; habitualmente el sistema inmunológico fabrica unas sustancias, llamadas anticuerpos que contribuyen a defendernos (por ejemplo de los gérmenes entre otras cosas). En el lupus, el sistema inmunológico forma, además de sustancias que nos defienden, otros anticuerpos dirigidos contra estructuras o tejidos propios normales llamados autoanticuerpos que pueden causar inflamación, dolor y daño en los tejidos, contribuyendo a las manifestaciones clínicas del Lupus Eritematoso Sistémico.

Si bien puede presentarse a cualquier edad tanto en niños como en ancianos es mas frecuente entre los 20 y 40 años, siendo más frecuente en mujeres que en varones.

La **evolución** de la enfermedad se desarrolla en fases de brote y otras en las que las manifestaciones de la enfermedad desaparecen llamado remisión.

Cuando hablamos de lupus, nos referimos en general al LES o lupus eritematoso sistémico, pero es importante recordar que existe también el Lupus cutáneo, el lupus inducido por medicamentos y el lupus neonatal.

Dentro de los lupus cutáneos: el riesgo de desarrollo de LES varía significativamente. Por ejemplo el Lupus Cutáneo Subagudo, tiene un riesgo de desarrollo de LES moderado (30-50%). Dentro del Lupus Cutáneo Crónico el Lupus Discoide tiene un riesgo bajo de desarrollar LES (5-10%).

SINTOMAS

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son: por un lado síntomas generales (como: el cansancio fácil, la pérdida de peso inexplicable, la fiebre que no se debe a ningún proceso infeccioso). Otras manifestaciones, dentro de las más frecuentes, son el dolor y la inflamación de las articulaciones (artritis) y los músculos (mialgias). El 90 por ciento de los pacientes con Lupus padecen artritis en manos, muñecas, codos, rodillas y pies con más frecuencia.

También es frecuente la afección en la piel. La lesión más conocida, aunque no la más frecuente, es la denominada “eritema en alas de mariposa”, que consiste en un enrojecimiento y erupción de la piel en las mejillas y la nariz que se brota con la exposición al sol (fotosensibilidad). Muy frecuentemente se produce en los enfermos con lupus la caída del cabello cuando la enfermedad está activa.

Cuando afecta al corazón y pulmones ocasiona diferentes síntomas desde dolor torácico y fiebre hasta dificultad para respirar (disnea) de intensidades variables dificultando esfuerzos hasta

actividades cotidianas. En otras ocasiones, el lupus afecta a los pulmones o a las válvulas del corazón ocasionando insuficiencia cardíaca y/o respiratoria.

El lupus puede afectar a los riñones (nefropatía lúpica). Los pacientes pueden manifestar aumento de su presión arterial (hipertensión) u orinas con espuma. La lesión más frecuente es la inflamación (nefritis), impidiendo que el riñón retenga las proteínas y elimine adecuadamente los residuos del organismo que se acumulan en la sangre, ocasionando hinchazón de la cara y piernas.

El sistema nervioso puede afectarse por el Lupus. Se manifiesta con dolores de cabeza (cefalea), cambios en el carácter y en ocasiones produce depresión y convulsiones. Son manifestaciones muy frecuentes en la población general, por lo que si un paciente con lupus las padece, hay que diferenciar si puede deberse a una inflamación cerebral por Lupus o por otras muchas circunstancias.

Es importante como paciente entender que el lupus puede ocasionar manifestaciones que sean visibles para otras personas (por ej las manchas en la piel) y otras que no (como el cansancio) , lo que puede dificultar la comprensión de la enfermedad por parte de otras personas.

El síndrome antifosfolípido

El llamado síndrome antifosfolípido es una enfermedad que produce unos anticuerpos especiales (anticuerpos anticardiolipina o anticuerpos para el anticoagulante lúpico) que pueden originar problemas en la coagulación, como trombosis arteriales o venosas y / o abortos a repetición. Esta enfermedad puede aparecer aislada o puede asociarse a otras enfermedades como el lupus. En esta situación es muy probable que se precise tomar medicación para evitar problemas en la coagulación.

Los síntomas del lupus son variables, los más frecuentes son:

- Dolor o inflamación de las articulaciones (artritis)
- Dolor de los músculos (mialgia)
- Fiebre inexplicable
- Manchas en la piel, más a menudo en la cara (rash)
- Dolor de pecho al respirar profundamente
- Caída fácil del cabello (alopecia)
- Dedos de las manos o de los pies pálidos o morados
- Sensibilidad al sol (fotosensibilidad)
- Hinchazón en las piernas o alrededor de los ojos
- Llagas en la boca (aftas)
- Cansancio (astenia)

- Dolor de cabeza (cefalea)
- Depresión
- Confusión (desorientación)
- Convulsiones.

Los síntomas pueden instalarse rápidamente y desaparecer. Cuando los síntomas aparecen se llaman brotes. Los brotes varían en intensidad. En cualquier momento pueden aparecer nuevos síntomas.

CAUSAS

Se desconoce la causa del lupus, y en los distintos pacientes puede haber distinta combinación de elementos que la originen o predispongan. Sin embargo, al tratarse de una enfermedad autoinmune, diferentes factores interactuarían pudiendo influir en el sistema inmunológico y provocando el Lupus. Así en personas genéticamente susceptibles la interacción de factores ambientales como la exposición a los rayos ultravioletas, virus, drogas o fármacos entre otras podrían desencadenar el Lupus. Es frecuente que los pacientes con lupus tengan familiares afectados con lupus o con otras enfermedades autoinmunes.

DIAGNOSTICO

No existe una única prueba específica para diagnosticar el lupus. La adecuada interpretación de los síntomas y el examen clínico completo permiten orientar el diagnóstico. En los análisis de sangre se puede detectar anticuerpos específicos que ponen en evidencia el desorden del sistema inmune, sin embargo algunos de éstos están relacionados con la actividad de la enfermedad y otros con manifestaciones clínicas de la misma.

El daño causado por el Lupus en órganos internos puede detectarse mediante los análisis de sangre y de orina, o bien con otros procedimientos como por ejemplo la biopsia renal o de piel serán de utilidad para determinar mejor el tratamiento.

TRATAMIENTO

El **objetivo** del tratamiento es:

- Prevenir los brotes
- Tratar los brotes cuando ocurren
- Reducir el daño de los órganos en el tiempo.
- Ayudar al sistema inmunitario a controlar la respuesta autoinmune
- Prevenir o reducir la limitación funcional.

Todo esto con los fármacos que presenten mejor evidencia para cada manifestación de LES que tenga el paciente, y que sea bien tolerado por el mismo. Por ello el tratamiento del LES es individualizado para cada paciente y para cada momento de la enfermedad.

Forma parte del tratamiento **informar al paciente** sobre la enfermedad brindándole las herramientas necesarias con **recomendaciones generales** que impactan sobre el estilo de vida. Se indica así evitar la exposición solar ya que la enfermedad se brota con los rayos ultravioletas, adecuar la actividad laboral y otras actividades como ejercicios físicos por a cada situación particular y momento de la enfermedad, y generarle al paciente y a la familia la contención necesaria para poder llevar adelante un tratamiento integral que variará según el órgano al que afecte.

El uso de antiinflamatorios tiene indicación para síntomas leves, y por tiempos muy cortos. El tratamiento debe ser integral para controlar los síntomas producidos por los órganos dañados como las articulaciones, la piel, el pulmón, el corazón, el sistema nervioso o el riñón.

Todos los pacientes con lupus sistémico deben recibir antipalúdicos por sus múltiples efectos beneficiosos sobre la enfermedad así como también suplementos de vitamina D por su rol protector sobre los huesos, músculos y sistema inmune.

Según los órganos afectados puede utilizarse corticoides en media a altas o en dosis bajas, y drogas inmunosupresores. También existen medicación biológica aprobada para su uso en lupus, tratamientos que colaboran en pacientes seleccionados a lograr la remisión de la enfermedad y evitar el daño de los órganos y lograr controlar la enfermedad con menor uso de corticoides. Entre estos biológicos se encuentra el anifrolumab y el belimumab. También hay experiencia en el uso de rituximab en pacientes refractarios (es decir que no responden a tratamientos habituales).

La alimentación debe de ser completa, sana y equilibrada. Por otro lado, cuando la enfermedad afecta al riñón y sobre todo, cuando hay hipertensión arterial, no es recomendable que consuman alimentos salados o condimentados.

Algunas veces se requieren, además de los medicamentos para el lupus, otros medicamentos para tratar otras situaciones que pueden o no tener que ver con el lupus o los tratamientos realizados para controlar a la enfermedad, tales como el colesterol alto, la presión arterial alta o infecciones.

BENEFICIOS DE UTILIZAR HIDROXICLOROQUINA EN PACIENTES CON LUPUS

ALGUNAS COSAS QUE TENÉS QUE SABER DE LA HIDROXICLOROQUINA:

- Los beneficios del uso de Hidroxicloroquina se conocen hace más de 50 años
- Todos los pacientes con Lupus deberían utilizarla, a no ser que haya alguna contraindicación, en cuyo caso tu médico te lo hará saber
- Se puede usar durante el embarazo
- Su acción no es inmediata, tarda en actuar algunas semanas y su efecto es pleno en 3 a 6 meses

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS:

- Mejora lesiones cutáneas debidas al Lupus
- Mejora Dolor articular

- Mejora la Fatiga
- Previene brotes de la enfermedad
- Disminuye el riesgo de formación de coágulos en venas o arterias en pacientes que además presentan anticuerpos Antifosfolipídicos
- Aumenta la densidad mineral ósea en pacientes con osteoporosis
- Reduce el colesterol total y la glucemia que son factores de riesgo conocidos para Infarto o ACV
- Mejora la sobrevida
- Disminuye el riesgo de daño de órganos internos

INFOREUMA (Sociedad Española de Reumatología)

Qué es el lupus eritematoso sistémico?

Lupus Eritematoso Sistémico (LES): qué es, síntomas, diagnóstico y tratamiento

El **lupus es una enfermedad autoinmune sistémica crónica**, es decir puede afectar a cualquier órgano. Esto hace que los síntomas sean muy diferentes entre pacientes, ya que dependen de los órganos que estén afectados. Por tanto, hay pacientes con síntomas muy leves y otros que pueden tener afectación de un órgano importante, lo que supone una enfermedad más grave.

El LES puede afectar: piel, articulaciones, riñones, corazón, pulmones, etc., pero la mitad de los pacientes con lupus tienen afectación casi exclusiva de la piel y las articulaciones. La piel es el órgano que se afecta con más frecuencia. El 80 % de los pacientes presentan alguna manifestación cutánea a lo largo de la enfermedad y alrededor del 25 % la afectación de la piel es el primer síntoma.

Las lesiones cutáneas que pueden aparecer en un paciente con LES son innumerables. Si bien el rash malar, una erupción o sarpullido facial en forma de alas de mariposa, es uno de los síntomas más frecuentes, ya que se puede observar en la mitad de los pacientes.

Las afectaciones que son más severas son la renal, del sistema nervioso central y, en algunos casos, la hematológica.

Se trata de una enfermedad crónica, que cursa en brotes, es decir se alternan periodos de actividad e inactividad a lo largo de la vida de las personas que lo padecen.

Lupus Eritematoso Sistémico (LES): qué es, síntomas, diagnóstico y tratamiento

¿Qué es un brote de lupus eritematoso sistémico?

Un brote de lupus eritematoso sistémico es un período de aumento de la actividad de la enfermedad, caracterizado por la aparición de nuevos síntomas o el empeoramiento de los ya existentes. Puede afectar a uno o varios órganos o sistemas, y su gravedad es variable. Los síntomas suelen acompañarse de alteraciones analíticas, entre las que pueden encontrarse

anemia, disminución de leucocitos y plaquetas, descenso del complemento, aumento de anti-DNA o aparición de hemáties, leucocitos o proteínas en la orina.

Cuál es la prevalencia de Lupus?

El **lupus eritematoso sistémico** afecta principalmente a mujeres. Cada persona tiene un patrón diferente de la enfermedad, lo que en ocasiones dificulta el diagnóstico. Esta patología se puede presentar a cualquier edad, pero lo más frecuente es que se inicie en la [juventud](#), por lo cual el diagnóstico precoz es sumamente importante.

El estudio EPISER del 2016 sobre prevalencia e impacto de las enfermedades reumáticas, realizado por la [Sociedad Española de Reumatología \(SER\)](#), evidencia una prevalencia de 0,21% de la población mayor de 20 años en España. En Argentina se calcula que hay entre 25 y 50 casos cada 100.000 habitantes.

Diagnóstico de Lupus

El diagnóstico del lupus, se basa en tres aspectos fundamentales: los síntomas que cuenta el paciente; el examen físico del paciente y los análisis de sangre y orina.

En los análisis de sangre y orina, el paciente con lupus eritematoso sistémico puede presentar algunas anomalías que hacen sospechar la enfermedad. Las pruebas más importantes son las que detectan la producción de autoanticuerpos, concretamente de los anticuerpos antinucleares (ANA). Sin embargo, no todas las personas que tienen estos anticuerpos tienen lupus ni van a desarrollarlo. Existen otros autoanticuerpos que sí son específicos del LES como el AntiADN o el Anti Sm.

Tratamiento de Lupus

El abordaje del tratamiento está basado en las necesidades específicas y los síntomas de cada paciente. Dado que las características del LES pueden variar de forma significativa entre diferentes individuos, es importante hacer hincapié en la importancia de los controles. La frecuencia de estas dependerá de cómo se encuentre y la gravedad.

Es fundamental protegerse del sol, ya que ayuda a prevenir brotes y a mantener la enfermedad controlada. La dieta equilibrada, variada, mediterránea es una herramienta que junto la [actividad física](#) y la mediación y pueden ayudar a controlar la actividad del LES.

Es aconsejable realizar [actividad física](#) de forma habitual, como caminar, nadar o andar en bicicleta, además de realizar ejercicios de fuerza, para prevenir la debilidad muscular. También hay que aprender a alternar las actividades habituales con periodos de descanso, para controlar la fatiga.

El tratamiento se adapta a cada persona según los síntomas y los órganos afectados, y puede incluir:

- **Antiinflamatorios y analgésicos**, para el dolor y la inflamación leve siempre que no exista contraindicación como puede ser la afectación del riñón

- **Antipalúdicos (como la hidroxicloroquina)**, que son la base del tratamiento para la mayoría de los pacientes, siempre que no exista contraindicación. Ayudan a controlar la enfermedad a largo plazo y a prevenir la aparición de brotes.
- **Corticoides**, utilizados para controlar brotes de la enfermedad, siempre intentando usar la dosis más baja posible y durante el menor tiempo posible.
- **Inmunosupresores** como la azatioprina, metotrexato, micofenolato o ciclofosfamida en función de las manifestaciones clínicas y los órganos afectados en cada paciente.

Nuevos tratamientos

En los últimos años, se han desarrollado **tratamientos biológicos**, que actúan de forma más específica sobre el sistema inmunitario. Entre ellos se encuentran anifrolumab y belimumab, indicados para el tratamiento del lupus. Además, otros tratamientos como rituximab, aunque no tienen indicación específica para lupus en su ficha técnica, han demostrado eficacia en la práctica clínica y pueden utilizarse en casos seleccionados.

Estos tratamientos han mejorado el control de la enfermedad en pacientes con lupus moderado o grave y han permitido reducir el uso prolongado de corticoides.

Qué deben hacer las mujeres con lupus que deseen quedarse embarazadas?

Las mujeres con lupus que desean tener un hijo/a deben planificar cuidadosamente el embarazo con su equipo médico para reducir riesgos y aumentar las probabilidades de un embarazo sin complicaciones.

Se recomienda una evaluación antes de buscar embarazo para revisar el estado actual del lupus, el nivel de actividad de la enfermedad, tipo de autoanticuerpos presentes y evaluar si la medicación que está recibiendo es compatible con el embarazo.

Se recomienda que el lupus esté controlado (en remisión) meses antes de quedar embarazada para reducir el riesgo de complicaciones (el tiempo puede variar según la actividad sea renal o extrarenal). Tampoco está recomendado buscar embarazo si su diagnóstico de LES es reciente, ya que los primeros tiempos de enfermedad pueden ser los de mayor actividad.

Es muy importante que la mujer lúpica que busca quedarse embarazada, no debe estar recibiendo fármacos que puedan dañar al bebé en gestación, por lo que siempre debe consultar con su médico el momento adecuado para buscar el embarazo, así como si la medicación que recibe (tanto por el lupus como por otras complicaciones asociadas por ej hipertensión arterial) son compatibles con la búsqueda de embarazo.

Qué complicaciones pueden tener las mujeres con lupus en el embarazo?

Una mujer con lupus puede tener un embarazo exitoso, pero también está aumentado el riesgo de ciertas complicaciones para la madre y el bebé que deben ser evaluadas cuidadosamente.

Entre las complicaciones que puede presentar *la madre* encontramos:

- Brotes de actividad: el embarazo puede reactivar la enfermedad, especialmente si antes de concebir la paciente no estaba en remisión mantenida. La situación de mayor riesgo es una nefritis lúpica previamente activa.
- Preeclampsia/Eclampsia. Es un trastorno que produce aumento de la tensión arterial, proteinuria y en ocasiones afectación de otros órganos. Esto puede resultar especialmente en pacientes con enfermedad activa, nefritis lúpica, síndrome antifosfolípido asociado u otros factores como hipertensión previa o mayor edad, entre otros.
- Trombosis: las pacientes con lupus especialmente en presencia de anticuerpos antifosfolípidos pueden presentar mayor riesgo de presentar trombos. De ahí la importancia de evaluar la presencia de ciertos autoanticuerpos previo al embarazo para poner un tratamiento adecuado durante el mismo y así reducir el riesgo.

Complicaciones del embarazo:

- Aborto espontáneo. Existe mayor riesgo en mujeres con anticuerpos antifosfolípidos.
- Parto prematuro: que puede ser originado por las propias complicaciones maternas como preeclampsia, brotes, etc.
- Restricción del crecimiento intrauterino: el bebé crece menos de lo esperado debido a problemas en la placenta.

Seguimiento durante el postparto de las mujeres con lupus?

Es fundamental el seguimiento en las primeras semanas y meses tras el parto. En este periodo existe mayor riesgo de brote donde se puede reactivar la actividad de la enfermedad, especialmente si se han tenido que suspender algunos tratamientos.

Es posible la lactancia teniendo lupus?

La lactancia puede ser posible y segura en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES), *siempre que se usen medicamentos compatibles.*

Los beneficios generales de la lactancia son bien conocidos como que promueve el vínculo madre-hijo, disminuye el riesgo de infecciones en el recién nacido, etc.

Se debe consultar con su médico los fármacos compatibles con la lactancia, ya que si la salud de la madre requiere el tratamiento con fármacos que no sean compatibles con la lactancia, el niño podrá recibir fórmula.

Autocuidados (Mayo clinic)

Si tienes lupus, toma medidas para cuidar tu cuerpo. Medidas sencillas pueden ayudarte a prevenir los brotes de lupus y, en caso de que aparezcan, a enfrentar mejor los signos y síntomas que presentes. Intenta lo siguiente:

- **Consulta a tu médico con regularidad.** Los controles periódicos, en lugar de consultar a tu médico solamente cuando tus síntomas empeoran, podrían ayudar al médico a prevenir

los brotes, y pueden ser útiles para abordar cuestiones de salud de rutina, como el estrés, la dieta y el ejercicio, los cuales pueden ayudar a prevenir las complicaciones del lupus.

- **Ten cuidado con el sol.** Debido a que la luz ultravioleta puede desencadenar un brote, usa ropa que te proteja, como un sombrero, una camisa de mangas largas y pantalones largos, y utiliza protectores solares con un factor de protección solar (FPS) de por lo menos 55 cada vez que salgas.
- **Haz ejercicio de forma regular.** El ejercicio puede ayudar a mantener los huesos fuertes, reducir el riesgo de ataque cardíaco y promover el bienestar general.
- **No fumes.** El tabaquismo aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, y puede empeorar los efectos del lupus en el corazón y los vasos sanguíneos.
- **Sigue una dieta saludable.** Una dieta saludable pone énfasis en frutas, verduras y cereales integrales. A veces es posible que tengas restricciones en la dieta, especialmente si tienes presión arterial alta, daño renal o problemas gastrointestinales.
- **Pregúntale a tu médico si necesitas vitamina D y suplementos de calcio.** Existe evidencia que indica que las personas con lupus pueden beneficiarse de la vitamina D complementaria. Un suplemento de calcio puede ayudarte a alcanzar la cantidad diaria recomendada en la dieta de 1000 miligramos a 1200 miligramos, dependiendo de tu edad, para ayudar a mantener los huesos sanos.

TENGO LUPUS, QUÉ PUEDO HACER PARA ESTAR MEJOR

QUÉ ES EL LUPUS?

- El **lupus** es una enfermedad autoinmune
 - El sistema inmunitario , en lugar de atacar elementos extraños como bacterias o virus, ataca elementos de nuestro propio organismo...
- Es una enfermedad *CRÓNICA* con momentos malos (**brotes**) y momentos buenos (remisiones)-

Existe el lupus...

- que afecta sólo la piel (**LUPUS CUTÁNEO**)
 - que afecta muchas partes del cuerpo (**LES** o LUPUS SISTÉMICO)
- Distintas personas pueden tener distintos síntomas...

NO HAY UN SOLO TRATAMIENTO, EL TRATAMIENTO SE ADAPTA A CADA PACIENTE Y A CADA MOMENTO DE LA ENFERMEDAD

QUÉ CAUSA EL LUPUS?

No se sabe!!!!

- Influyen:

- Las hormonas (más frecuente en mujeres, pero también se da en hombres y en niños)
- La radiación ultravioleta , que está en el SOL
- El stress
- Tener familiares con problemas inmunológicos (autoinmunes), es decir la genética

Más cosas sobre el lupus...

- El lupus **NO ES CONTAGIOSO** por ninguna vía.
- El lupus no es parecido ni tiene relación con el cáncer.
- El lupus no es causado ni está relacionado al virus del HIV /SIDA.
- En algunos pacientes es una enfermedad **leve** y en otros muy **grave**

Puede el lupus asociarse a otras enfermedades autoinmunes?

- **SÍ**, varias enfermedades autoinmunes pueden asociarse al lupus. Un terreno genético común está probablemente en el origen de estas asociaciones. El síndrome de Sjögren (una enfermedad autoinmune que se manifiesta principalmente por la sequedad de la boca y/o de los ojos) puede estar asociada al lupus, en un 20% de los casos.
- El síndrome de anticuerpos antifosfolípido, caracterizado por la formación de coágulos sanguíneos (trombosis) en las arterias o las venas, y unos anticuerpos concretos, está a menudo asociado también al lupus.
- Otras enfermedades autoinmunes sistémicas, como las miopatías inflamatorias o la esclerodermia, pueden estar asociadas al lupus: es lo que se denomina síndrome de superposición.
- Por último, el lupus puede estar asociado a enfermedades autoinmunes "localizadas", como la tiroiditis o la miastenia gravis.

¡Ahora vamos a repasar algunas cosas que nos hacen sentir mejor y mantener el lupus bien controlado!

- 1) **CUIDARNOS DEL SOL Y LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA**
 - a. Usar protector solar (40 o más de FPS), gorras, sombreros, camisas blancas...
- 2) **NO TOMAR ANTICONCEPTIVOS ORALES NI OTROS TRATAMIENTOS HORMONALES, A MENOS QUE NUESTRO MÉDICO NOS LO AUTORICE EXPRESAMENTE**
 - a. Los tratamientos hormonales pueden favorecer los brotes de lupus, por ello
 - b. cuando el lupus está muy activo, **no** es conveniente tomar anticonceptivos orales que contengan estrógenos.
 - c. hay pacientes que tienen sustancias en su sangre que favorecen la formación de coágulos (anticuerpos antifosfolípidicos) y estos pacientes en particular nunca deben tomar anticonceptivos orales

- 3) EN LAS MUJERES LOS EMBARAZOS DEBEN SER PLANIFICADOS, EN MOMENTOS EN QUE LA ENFERMEDAD ESTÉ INACTIVA
- 4) EN MUJERES Y VARONES HAY QUE CONVERSAR CON EL MÉDICO CUANDO SE PLANEE BUSCAR EMBARAZO, PORQUE MUCHOS REMEDIOS NO SON COMPATIBLES CON EL EMBARAZO
- 5) **NO HAY DIETAS QUE CUREN EL LUPUS, NI DIETAS QUE EMPEOREN EL LUPUS POR SÍ MISMO**
- 6) **SIN EMBARGO TENER UNA DIETA SALUDABLE** (BAJA EN GRASAS SATURADAS, RICA EN FIBRAS, QUE INCLUYA FRUTAS Y VERDURAS, con POCA SAL) **AYUDA A LA SALUD EN GENERAL Y A TENER MEJOR LA CIRCULACIÓN**
- 7) TOMAR LA MEDICACIÓN INDICADA por nuestro médico, A LAS DOSIS INDICADAS...
- 8) AVISAR CUANDO UNA MEDICACIÓN NOS HAGA MAL
- 9) CONCURRIR A LOS CONTROLES, que variarán en su frecuencia según la actividad del lupus
- 10) Control oftalmológico al menos 1 vez al año cuando se tomen antipalúdicos
- 11) LOS CONTROLES PERIÓDICOS PERMITIRÁN:
 - a. Detectar nuevos síntomas
 - b. Prevenir brotes o complicaciones del lupus
 - c. Ajustar su plan de tratamiento
 - d. Detectar posibles efectos secundarios de los medicamentos.
- 12) Los pacientes con lupus pueden (y deben) RECIBIR LAS VACUNAS indicadas en inmunosuprimidos (por ej Neumococo, gripe, herpes zoster, entre otras). También la vacuna del HPV si su médico se la indica.
 - a. No se deben recibir VACUNAS a virus vivos (siempre consultar con su médico). Entre las vacunas a virus vivo se encuentran la de la fiebre amarilla, la del Dengue y la de Sarampión-Rubeola y paperas..
 - b. Si es posible , debe evitarse la vacunación en momentos de brote de la enfermedad. Entre otros motivos, porque si se requiere elevar las dosis de corticoides e inmunosupresores, puede disminuir la efectividad de las vacunas. Sin embargo si el paciente no ha podido ser vacunado fuera del brote de lupus, la vacunación durante el mismo es posible, y no está contraindicada.
- 13) **El cansancio...**
 - a. Muchas personas con Lupus tienen cansancio o fatiga.
 - b. Hay que prestar atención y “escuchar” al cuerpo, no exigirse de más.
 - c. Descansar al menos **8 hs** en la noche y **1 h** en la siesta.
 - d. Alternar en el día trabajo y descanso.
 - e. No culparse por estar fatigado y explicar a la familia que es parte de la enfermedad.
- 14) Ejemplos de actitudes para manejar mejor el stress:
 - a. Tener actividades recreativas que podamos realizar y nos gusten
 - b. Participar de actividades sociales, no aislarnos
 - c. Practicar ejercicio físico suave o con estiramientos o ejercicios en agua
 - d. Practicar yoga

15) Puedo modificar por mi decisión las dosis de tratamiento, por ejemplo de corticoides?.

Esto no está recomendado, sobre todo:

- a. Nunca se debe suspender el corticoide en forma brusca (siempre hacerlo bajo indicación médica, y del modo q su médico se lo indique).
- b. No deben aumentarse ni disminuirse los tratamientos sin consejo médico y

Es fundamental que el paciente tenga un papel activo en su tratamiento. Debe estar informado y colaborar con el equipo médico para poder reducir el impacto de la enfermedad. Reconocer las señales de alerta antes de que ocurra un brote, pueden ayudar a prevenirlo tomando las medidas iniciales evitando que sean menos fuertes.

Esta información para pacientes está basada en material desarrollada por el Servicio de inmunología del Hospital Central de Mendoza, material disponible en la web de la Sociedad Argentina de Reumatología, Sociedad Española de Reumatología, Sociedad Española de Inmunología y la Mayo Clinic.